



Cartilha de Acolhimento aos Novos Gestores do Programa Municipal de Alimentação e Nutrição

Criado por: Coordenação Estadual de Nutrição



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



MINISTÉRIO DA
SAÚDE





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DIRETORIA DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE
COORDENAÇÃO ESTADUAL DE NUTRIÇÃO



Cartilha de Acolhimento aos Novos Gestores do Programa Municipal de Alimentação e Nutrição

1º EDIÇÃO

PARÁ
FEVEREIRO/2021

COORDENAÇÃO DE
ESTADUAL DE NUTRIÇÃO

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Governador do Estado do Pará

Helder Zaluth Barbalho

Secretário de Estado de Saúde Pública

Rômulo Rodovalho Gomes

Secretário Adjunto de Gestão de Políticas em Saúde

Sipriano Ferraz Santos Junior

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Ariel Dourado Sampaio Martins de Barros

Diretora de Políticas de Atenção Integral à Saúde

Laena Costa dos Reis

Diretora do Departamento de Atenção à Saúde

Ana Paula Oliva Reis

Coordenadora Estadual de Nutrição

Walkíria de Moraes Silva

Organizadores:

Thaís Granado Santos, Walkíria de Moraes Silva, Amujacy Tavares Vilhena, Laena Costa do Reis, Ana Paula Oliva Reis e Livia Tomé de Lima França

Sumário

Apresentação	5
Conheça a Coordenação Estadual de Nutrição (CEN)	6
POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (PNAN)	8
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)	13
PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A (PNSVA)	17
FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	19
SISTEMA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.....	20
ESTRATÉGIA DE FORTIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COM MICRONUTRIENTES EM PÓ - NUTRISUS	23
PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL	24
ESTRATÉGIA PARA O FORNECIMENTO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS.....	27
Referências	36

Apresentação

Caro coordenador (a),

A alimentação e a nutrição (A&N) constituem requisitos básicos para a promoção e a proteção da saúde, possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania. No plano individual e em escala coletiva, esses atributos estão consignados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada há 50 anos, os quais foram posteriormente reafirmados no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966) e incorporados à legislação nacional em 1992.

Os riscos nutricionais, de diferentes categorias e magnitudes, permeiam todo o ciclo da vida humana, desde a concepção até a velhice, assumindo diversas configurações epidemiológicas em função do processo saúde/doença de cada população, cabendo ao Estado respeitar, proteger e facilitar a ação do indivíduo, famílias e comunidades, no que tange ao bem-estar físico, mental e social.

Nesse sentido, e sabendo do impacto que as ações de alimentação e nutrição têm na vida das pessoas, esta publicação tem o objetivo de apoiar e orientar acerca da execução dos programas e ações relacionados à Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), fortalecendo e potencializando do trabalho da Atenção Primária à Saúde (APS).

Assim, a Coordenação Estadual de Nutrição (CEN) deseja boas vindas aos gestores municipais da PNAN e se coloca à disposição para orientações e esclarecimentos necessários.

Que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu alimento.

Hipócrates

Conheça a Coordenação Estadual de Nutrição (CEN)

A Coordenação Estadual de Nutrição (CEN) faz parte do Departamento de Atenção à Saúde (DASE) e Diretoria de Políticas de Atenção Integral à Saúde (DPAIS), sendo responsável por coordenar, assessorar, capacitar gestores e profissionais, monitorar e avaliar as ações da Política de Alimentação e Nutrição – PNAN executadas pelos 144 municípios do Estado de forma contínua e sistemática.

A CEN atua ainda com objetivo de:

- Planejar, orientar, coordenar, supervisionar e avaliar o processo de implementação da PNAN, visando a melhoria das condições nutricionais da população, observando os princípios do SUS;
- Propor, planejar, normatizar, gerenciar, monitorar e avaliar, em âmbito estadual e municipal, a execução de planos, programas, projetos, ações e atividades necessárias à concretização da PNAN;
- Articular-se com municípios, através dos CRS, de modo a estimular sua adesão aos programas e projetos na área de alimentação e nutrição e prestar-lhes cooperação técnica para o aperfeiçoamento da capacidade gerencial e operacional nessa área;
- Promover a articulação com órgãos e entidades de fomento/financiamento à pesquisa para desenvolvimento de projetos de cooperação e estudos nas áreas de alimentação e nutrição;
- Promover e incentivar a educação continuada dos recursos humanos envolvidos na implementação dos programas/projetos da PNAN, através da realização de seminários, encontros etc. e participação em eventos técnico-científicos;
- Fomentar e participar de atividades intersetoriais para o planejamento e implementação da política e de planos, programas, projetos e atividades de segurança alimentar e nutricional sustentável.

As atividades da CEN são desenvolvidas em parceria com os 13 Centros Regionais de Saúde (CRS) do Estado, que oferecem aos gestores municipais:

- Auxílio quanto ao planejamento e organização das ações e estratégias da PNAN;
- Monitoramento e avaliação dos programas e ações da PNAN;
- Ações de educação permanente para gestores e profissionais de saúde de acordo com as características e necessidades específicas dos municípios e regiões.

A equipe é composta por:

Coordenadora Estadual de Nutrição
Walkíria de Moraes Silva

Referência Técnica da PNAN 5º CRS
Andrea Dutra

Equipe Técnica CEN
Darlene Ramos
Maria de Nazaré Araújo Lima
Mariana Borges Petroli
Thaís Granado Santos

Referência Técnica da PNAN 6º CRS
Simone Silva

Referência Técnica da PNAN 7º CRS
Viviane Almeida

Assistentes administrativos nível central
Lívia Tomé de Lima França

Referência Técnica da PNAN 8º CRS
Mariene Nascimento

Referência Técnica da PNAN 1º CRS
Débora Santa Brígida

Referência Técnica da PNAN 9º CRS
Rilda Jati

Referência Técnica da PNAN 2º CRS
Waleska Raiol

Referência Técnica da PNAN 10º CRS
Francemary Silva

Referência Técnica da PNAN 3º CRS
Crystiane Castro

Referência Técnica da PNAN 11º CRS
Taciana Miranda

Referência Técnica da PNAN 4º CRS
Nazaré Medeiros

Referência Técnica da PNAN 12º CRS
Nalva Silva

Referência Técnica da PNAN 13º CRS
Raquel Moreira



POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (PNAN)

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) foi aprovada inicialmente em 1999, integrando os esforços do Estado Brasileiro que, por meio de um conjunto de políticas públicas, propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação.

Em 2012, a PNAN foi revisada e atualizada por meio da Portaria nº 2.715, de 17/11/2011, apresentando-se com o propósito de melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde em busca da garantia da Segurança Alimentar e Nutricional da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição.

A PNAN está organizada em diretrizes que abrangem o escopo da atenção nutricional no Sistema Único de Saúde (SUS) com foco na vigilância, promoção, prevenção e cuidado integral de agravos relacionados à alimentação e nutrição; cujas atividades são integradas às demais ações de saúde nas redes de atenção, tendo a atenção primária à saúde como ordenadora das ações.

PRINCÍPIOS

A alimentação como elemento de humanização das práticas de saúde:

A alimentação expressa as relações sociais, os valores e a história do indivíduo e dos grupos populacionais e tem implicações diretas na saúde e na qualidade de vida. Essa abordagem contribui para o conjunto de práticas ofertadas pelo setor saúde, na valorização do ser humano, para além da condição biológica e o reconhecimento de sua centralidade no processo de produção de saúde.

O respeito à diversidade e à cultura alimentar:

A alimentação brasileira, com suas particularidades regionais, exige diversas atitudes como reconhecer, respeitar, preservar, resgatar e difundir a riqueza incomensurável de alimentos e práticas alimentares correspondem ao desenvolvimento de ações com base no respeito à identidade e cultura alimentar da população.

O fortalecimento da autonomia dos indivíduos:

O fortalecimento ou ampliação dos graus de autonomia para as escolhas e práticas alimentares implica em aumento da capacidade de interpretação e análise do sujeito sobre si e sobre o mundo e, por outro, à capacidade de fazer escolhas, governar e produzir a própria vida. Para isso, deve-se investir em instrumentos e estratégias de comunicação e educação em saúde que apoiem os profissionais de saúde em seu papel de socialização do conhecimento e da informação sobre A&N e de apoio aos indivíduos e coletividades na escolha por práticas promotoras da saúde.

A determinação social e a natureza interdisciplinar e intersetorial da alimentação e nutrição:

O conhecimento das determinações socioeconômicas e culturais da A&N dos indivíduos e coletividades contribui para a construção de formas de acesso a uma alimentação adequada e saudável, colaborando com a mudança do modelo de produção e consumo de alimentos que determinam o atual perfil epidemiológico.

A segurança alimentar e nutricional com soberania:

A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é estabelecida no Brasil como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

DIRETRIZES



Estímulo às ações intersetoriais:

Na condição de detentor dos dados epidemiológicos relativos aos aspectos favoráveis e desfavoráveis da A&N, no âmbito estadual, o setor saúde deverá promover articulação com outros setores governamentais, a sociedade civil e o setor produtivo, cuja atuação esteja relacionada a determinantes que interferem de forma positiva ou negativa no estado nutricional do indivíduo e que tem repercussão na sua saúde e qualidade de vida.

Monitoramento da situação alimentar e nutricional:

A correta obtenção e a plena utilização de dados e informações por meio do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) compreende a descrição contínua e a predição de tendências das condições de A&N da população, bem como de seus fatores determinantes. O diagnóstico descritivo e analítico dos problemas e seus fatores determinantes deverá caracterizar áreas geográficas, segmentos sociais, grupos populacionais e biológicos de maior risco. No monitoramento da situação alimentar e nutricional, o SISVAN deverá concentrar informações obtidas na atenção básica em saúde (ABS), inclusive considerando o compromisso de universalização.

Promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis:

Deve ser iniciada com o incentivo ao aleitamento materno e permanecer inserida no contexto da adoção de estilos de vida saudáveis, componente importante da promoção da saúde. Nesse sentido, ênfase será dada à socialização do conhecimento sobre os alimentos e o processo de alimentação, bem como da prevenção dos problemas nutricionais, como a desnutrição, as carências nutricionais específicas e a obesidade.

Prevenção e controle dos distúrbios nutricionais e doenças associadas à A&N:

A inexistência de uma divisão clara entre as medidas institucionais específicas de nutrição e as intervenções convencionais de saúde exige uma atuação baseada em duas situações polares. Na primeira, prevalece um quadro de morbimortalidade, dominado pelo binômio desnutrição energético-protéica (DEP)/infecção, que afeta, principalmente, as crianças oriundas de famílias de baixa renda, nas regiões remotas e de baixo nível econômico e social. Na segunda, está o grupo predominante do sobrepeso e obesidade, diabetes *mellitus*, doenças cardiovasculares e algumas afecções neoplásicas, denominadas Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), cujas medidas estarão voltadas para o controle dos desvios alimentares e nutricionais e à promoção de atividade física, por constituírem as condutas mais eficazes para prevenir sua instalação e evolução. Também serão assegurados cuidados nutricionais e atenção básica de saúde a principais carências nutricionais específicas, como anemia por carência de ferro, hipovitaminose A, entre outras, além do fornecimento de fórmulas nutricionais especiais (FNE - dietas enterais, fórmulas infantis e/ou suplementos alimentares), para o atendimento aos usuários do SUS que necessitam desses insumos para o controle de determinadas patologias.

Promoção de linhas de investigação:

A implementação de todas as diretrizes da PNAN no âmbito estadual contará com o suporte de linhas de investigação desenvolvidas de acordo com as normas da Comissão de Ética em Pesquisa Humana do Ministério da Saúde. Estas normas esclarecem aspectos particulares e até gerais de alguns problemas, avaliam a contribuição dos fatores causais envolvidos e indicam as medidas mais apropriadas para seu controle.

Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos:

O desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos constituem diretriz que perpassa todas as demais definidas nesta Política, configurando mecanismo privilegiado de articulação intersetorial, de forma que o setor saúde possa dispor de pessoal em qualidade e quantidade, e cujo provimento, adequado e oportuno, é de responsabilidade do Estado e do Município.

RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS NA EXECUÇÃO DA PNAN

Responsabilidades do Gestor Estadual – Secretaria Estadual de Saúde

- Preparar e fornecer informações, análises e propostas que subsidiem a elaboração e o monitoramento das ações que garantam o respeito, o acesso e a concretização do DHAA;
- Implementar e avaliar a operacionalização das diretrizes e prioridades da PNAN no âmbito estadual;
- Estabelecer normas, prestar cooperação técnica e apoio técnico-científico aos municípios voltadas à implementação da PNAN, sistematizando, inclusive, medidas de prevenção e manejo de problemas de nutrição em nível individual, familiar e comunitária;
- Promover mecanismos de consolidação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), inclusive ampliando a sua abrangência em termos técnicos e geográficos, para fins de mapeamento e monitoramento do estado nutricional da população;
- Orientar e apoiar os municípios quando solicitado, em seus processos de distribuição e controle da utilização de insumos estratégicos (vitamina A, ferro e NutriSUS), contribuindo para que este processo esteja consoante à realidade alimentar e nutricional e para que seja assegurado o atendimento ao público-alvo de forma oportuna e regular;
- Aplicar corretamente os recursos financeiros repassados pelo Ministério da Saúde, por meio do Fundo de Alimentação e Nutrição (FAN), nas atividades previstas no PPA, PAS e outros instrumentos de planejamento e controle das ações de saúde a serem executadas no âmbito estadual.
- Apoiar os municípios na utilização correta do FAN, repassados fundo a fundo aos municípios, bem como na construção de planos, programas, projetos e atividades adequados às diretrizes e prioridades da PNAN;
- Realizar estudos, bem como, estimular e apoiar os municípios na realização de pesquisas consideradas estratégicas no contexto da PNAN;
- Promover a disseminação de informações técnico-científicas e de experiências exitosas referentes à alimentação e nutrição;
- Promover a capacitação de recursos humanos para a implementação dos programas e estratégias da PNAN no Estado;
- Promover a adoção de práticas e hábitos de alimentação saudáveis, mediante a mobilização de diferentes segmentos da sociedade e por intermédio da mídia;
- Promover e apoiar os municípios no controle social da execução da PNAN

Responsabilidades do Gestor Municipal – Secretaria Municipal de Saúde

- Coordenar e executar ações previstas na PNAN, no âmbito municipal, definindo componentes específicos que devem ser implementados pelo município.
- Aplicar corretamente os recursos financeiros repassados pelo Ministério da Saúde, por meio do FAN, nas atividades previstas no PPA, PAS e outros instrumentos de planejamento e controle das ações de saúde a serem executadas no âmbito municipal.
- Receber e/ou adquirir suplementos nutricionais (ferro e vitamina A e NutriSUS), garantindo o abastecimento de forma permanente e oportuna, bem como a sua dispensação adequada a todas as Unidades.
- Promover as medidas necessárias para integrar a programação municipal àquela proposta pelo Estado.
- Promover o treinamento e a capacitação de recursos humanos para operacionalizar, de forma produtiva e eficaz, o elenco de atividades específicas na área de A&N.
- Operacionalizar o componente municipal de sistemas nacionais básicos para a implementação desta

Política, de que são exemplos o de Vigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de Rede de Laboratórios de Saúde Pública.

- Promover mecanismos de consolidação do componente municipal do SISVAN, estabelecendo a atualização dos sistemas de informação e análise dos dados compilados (antropometria e consumo alimentar), como prática contínua e regular.
- Implantar, na rede de serviços, o atendimento da clientela portadora de agravos nutricionais clinicamente instalados, envolvendo a assistência alimentar, o controle de doenças intercorrentes e a vigilância dos contatos, garantindo a simultaneidade da execução de ações específicas de nutrição e das convencionais de saúde e criando suporte legal para o atendimento a essa parcela da população.
- Associar-se a outros municípios, inclusive na forma de consórcios, de modo a prover o atendimento de sua população nas questões referentes à A&N, especialmente na construção de Linhas de Cuidado a agravos específicos.
- Promover e garantir a participação do controle social na execução desta Política.





PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)

Criado pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, é um programa federal de transferência direta de renda que atende família em situação de pobreza e extrema pobreza, contribuindo para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. O recebimento do auxílio está vinculado ao cumprimento de compromissos assumidos pelas famílias e pelo poder público nas áreas de saúde, educação e assistência social.

O cadastro das famílias é feito por meio do Cadastro Único. Porém o cadastro não garante a entrada imediata no Bolsa Família. A seleção das famílias é feita por um sistema informatizado, a partir dos dados que elas informaram no Cadastro Único e das regras do programa e é necessária a atualização cadastral sempre que houver alteração na composição familiar, alteração de endereço, aumento ou diminuição da renda, mudança de escola, entre outros.

O programa possui três eixos principais: o complemento da renda; o acesso a direitos e a articulação com outras ações a fim de estimular o desenvolvimento das famílias.

- **Complemento da renda** - todos os meses, as famílias atendidas pelo Programa recebem um benefício em dinheiro, que é transferido diretamente pelo governo federal. Esse eixo garante o alívio mais imediato da pobreza.
- **Acesso a direitos** - as famílias devem cumprir alguns compromissos (condicionalidades), que têm como objetivo reforçar o acesso à educação, à saúde e à assistência social. Esse eixo oferece condições para as futuras gerações quebrarem o ciclo da pobreza, graças a melhores oportunidades de inclusão social.
- **Articulação com outras ações** - o Bolsa Família tem capacidade de integrar e articular várias políticas sociais a fim de estimular o desenvolvimento das famílias, contribuindo para superarem a situação de vulnerabilidade e de pobreza.

BENEFÍCIOS

O valor que a família recebe por mês é a soma de vários tipos de benefícios previstos no Programa Bolsa Família. Os tipos e as quantidades de benefícios que cada família recebe dependem da composição (número de pessoas, idades, presença de gestantes etc.) e da renda da família beneficiária.

- **Benefício Básico:** No valor de R\$ 89, pago apenas a famílias extremamente pobres (renda mensal por pessoa de até R\$ 89,00).

- **Benefícios Variáveis:** no valor de R\$ 41 cada um (até cinco por família):

- **Benefício Variável Vinculado à Criança ou ao Adolescente de 0 a 15 anos:** Pago às famílias com renda mensal de até R\$ 178,00 por pessoa e que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 15 anos. É

exigida frequência escolar de crianças e adolescentes entre 6 a 15 anos.

- **Benefício Variável Vinculado à Gestante:** Pago às famílias com renda mensal de até R\$ 178 por pessoa e que tenham grávidas em sua composição, por meio do pagamento de nove parcelas mensais. O benefício só é pago se a gravidez for identificada pela área de saúde e inserida no Sistema PBF na Saúde (BFA) no e-Gestor AB.
- **Benefício Variável Vinculado à Nutriz:** Pago às famílias com renda mensal de até R\$ 178 por pessoa e que tenham crianças com idade entre 0 e 6 meses em sua composição, para reforçar a alimentação do bebê, mesmo nos casos em que o bebê não more com a mãe, por meio do pagamento de seis parcelas mensais. Para que o benefício seja concedido, a criança precisa ter seus dados incluídos no Cadastro Único até o sexto mês de vida.
- **Benefício Variável Vinculado ao Adolescente:** no valor de R\$ 48 (até dois por família), é pago às famílias com renda mensal de até R\$ 178 por pessoa e que tenham adolescentes entre 16 e 17 anos em sua composição. É exigida frequência escolar dos adolescentes.
- **Benefício para Superação da Extrema Pobreza:** em valor calculado individualmente para cada família. Pago às famílias que continuem com renda mensal por pessoa inferior a R\$ 89,00, mesmo após receberem os outros tipos de benefícios do Programa. O valor do benefício é calculado caso a caso, de acordo com a renda e a quantidade de pessoas da família, para garantir que a família ultrapasse o piso de R\$ 89,00 de renda por pessoa.

CONDICIONALIDADES

Na saúde, semestralmente deve ser realizado o acompanhamento do calendário vacinal, crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 7 anos e o acompanhamento de mulheres de 14 a 44 anos e das gestantes de qualquer idade, verificando o pré-natal das gestantes e o acompanhamento das nutrizes, sendo necessário o registro dos dados no sistema BFA ou pelo e-SUS AB:

Gestantes:

Antropometria: aferição e registro de peso e altura, por meio do qual são feitas a avaliação do estado nutricional e as orientações necessárias;

Pré-Natal: verificação se a gestante está realizando acompanhamento pré-natal e, caso não esteja, deverá iniciá-lo.

Data da última menstruação (DUM): deve ser registrado, a partir do qual será calculado o fornecimento das parcelas referente ao benefício variável à gestante.

Mulheres não gestantes (14 a 44 anos):

Antropometria: aferição e registro de peso e altura, por meio do qual é feito a avaliação do estado nutricional e orientações necessárias;

É importante preencher o campo referente à situação gestacional, informando se não está gestante ou se não pode ser gestante.

Crianças (até 7 anos):

Antropometria: aferição e registro de peso e altura, por meio dos quais são feitas a avaliação do estado nutricional e orientações necessárias;

Verificação da cobertura vacinal e encaminhamento para atualização, caso não esteja atualizado o

calendário vacinal.

GESTÃO

A gestão do PBF é compartilhada, intersetorial e descentralizada. Ou seja, tanto a União, quanto os Estados, o Distrito Federal e os municípios têm atribuições em sua execução. Em nível federal, o Ministério da Cidadania é o responsável pelo Programa e a Caixa Econômica Federal é o agente que executa os pagamentos. Conforme a Portaria Interministerial MS/MDS nº 2.509, de 18 de novembro de 2004, compete às Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e às Secretarias Municipais de Saúde (SMS) no Programa Bolsa Família indicar um responsável técnico – profissional de saúde – para coordenar o acompanhamento das pessoas do Programa Bolsa Família, sendo recomendado, preferencialmente, um nutricionista, que deve estar lotado na Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde.

Gestão Municipal do PBF - Saúde

- Indicar um responsável técnico – profissional de saúde – para coordenar o acompanhamento das condicionalidades do PBF no âmbito da saúde;
- Prover, semestralmente, o acompanhamento das condicionalidades de saúde dos beneficiários do PBF;
- Coordenar o processo de inserção e atualização das informações de acompanhamento no Sistema de Gestão do PBF na Saúde;
- Estimular e mobilizar as famílias para o cumprimento das condicionalidades de saúde;
- Capacitar as equipes de saúde para o acompanhamento de gestantes e crianças do PBF;
- Informar ao órgão municipal responsável pelo PBF/Cadastro Único qualquer alteração identificada sobre os dados cadastrais dos beneficiários do PBF.
- As Secretarias Municipais de Saúde poderão estabelecer parcerias com órgãos e instituições municipais, estaduais e federais, governamentais e não-governamentais para o fomento de atividades complementares às famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família.

Sistema de Gestão do PBF na Saúde (Sistema BFA)

Contém o nome de todas as pessoas da família que precisam ser acompanhadas nessa condicionalidade. No Sistema BFA, disponível na plataforma e-Gestor Atenção Básica através do link <https://egestorab.saude.gov.br>, as áreas de saúde dos municípios registram as informações referentes ao peso, altura e vacinação das crianças, bem como o pré-natal realizado com as gestantes identificadas durante a vigência. O Sistema tem como principais funcionalidades:

- Receber o registro dos dados de acompanhamento das condicionalidades de saúde de todos os integrantes da família que precisam ser acompanhados pelas equipes de saúde nos municípios;
- Possibilitar consulta de informações, por integrante, sobre o cumprimento ou não das condicionalidades de saúde: realização do pré-natal, atendimento ao calendário de vacinação e registro de peso e altura das crianças menores de sete anos;
- Gerar relatórios com os resultados de acompanhamento da saúde, que servem como instrumentos de diagnóstico, avaliação e monitoramento para a atuação do poder público;
- Enviar ao Ministério da Cidadania os resultados do acompanhamento das condicionalidades de saúde dos beneficiários do PBF.

Atenção: Os relatórios com resultados consolidados são disponibilizados por vigência e possuem acesso

público. Entretanto, os gestores municipais e coordenadores estaduais do PBF podem realizar consultas a dados analíticos do acompanhamento das condicionalidades de saúde no Sistema de Gestão do PBF na Saúde, mediante perfil de acesso cadastrado na plataforma e-Gestor Atenção Básica.

ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA

Acompanhar e registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica e no mapa de acompanhamento do Programa Bolsa Família (PBF) as condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias;

ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD)

O IGD é um recurso repassado para o fundo de Assistência Social dos Estados e Municípios de acordo com o desempenho do acompanhamento das condicionalidades da saúde, da educação, bem como a taxa de atualização do cadastro único realizado pela Assistência Social. Consiste em um índice que varia de 0 a 1 e mostra a qualidade da gestão do PBF nos Estados e Município e, com base no desempenho neste indicador, o MDS repassa recursos mensalmente para o Fundo Municipal da Assistência Social com vistas a fortalecer a gestão intersetorial do PBF (assistência social, saúde e educação).

COMITÊ INTERSETORIAL DE GESTÃO DO PBF

É instância de gestão que deve ser formada nos Municípios e Estados para que os gestores do programa (saúde, educação e assistência social) possam se reunir para socializar os problemas, obstáculos, dificuldades, bem como as potencialidades locais para o avanço das ofertas dos serviços públicos de saúde, educação e assistência social às famílias do PBF.





PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A (PNSVA)

O Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de Saúde, desenvolve, desde o dia 13 de maio de 2005 (Portaria MS nº729/2005), o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (PNSVA), cujo objetivo é reduzir e controlar a hipovitaminose A, a mortalidade e morbidade em crianças de 6 a 59 meses de idade.

A partir de 2012 o programa foi expandido para todas as crianças na faixa etária residentes nas Regiões Norte e Nordeste e em diversos municípios das Regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, além dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Em outubro de 2017, tivemos a implantação do Sistema de Micronutrientes com os módulos de Ferro, NutriSUS e Vitamina A. O monitoramento do PNSVA está ativo na plataforma do e-gestor, no Sistema de Micronutrientes– Módulo Vitamina A.

O PNSVA inclui a distribuição de cápsulas de vitamina A na forma líquida, diluída em óleo de soja e acrescida de vitamina E, em duas dosagens: 100.000 UI e 200.000 UI, acondicionadas em frascos, contendo, cada um, 50 cápsulas gelatinosas moles. As cápsulas apresentam cores diferentes, de acordo com a concentração de vitamina A: amarela de 100.000 UI e vermelha de 200.000 UI.

Em 06 de junho de 2016, por meio da Nota Técnica nº135/2016 CGAN/DAB/SAS/M, foi encerrada a suplementação de vitamina A para puérperas, em decorrência da inexistência de fortes evidências da indicação dessa suplementação como medida de saúde pública.

A Secretaria de Saúde do Pará (SESPA), através da Coordenação Estadual de Nutrição (CEN), faz a gestão do processo de distribuição do insumo aos 144 municípios, jurisdicionados aos 13 Centros Regionais de Saúde (CRS), além do monitoramento do programa, por meio de sistemas de informação e contato direto com os coordenadores regionais e municipais da PNAN em todo o Estado.

O compromisso da CEN/SESPA é que esse insumo chegue a toda a população do Pará, com segurança, qualidade e responsabilidade. Para tanto procura-se aprimorar todas as etapas da logística de distribuição, capacitação dos servidores envolvidos e acompanhamento sistemático da cobertura do programa, a partir dos dados disponibilizadas no sistema e-gestor e cobrança no estoque do produto no município e nas regionais. Vale a pena ressaltar a importância que os coordenadores estaduais, regionais e municipais tem para que o objetivo do PNSVA seja alcançado no Estado.

A partir de 2021, a Coordenação Estadual de Nutrição colocou em prática um novo monitoramento para as ações do PNSVA no Estado do Pará, com o objetivo de auxiliar na execução do programa. Dividimos em:

LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DO INSUMO

- a. Pedido - Os coordenadores municipais deverão fazer dois pedidos anuais (1º e 2º semestre), dentro de suas metas que devem ser retiradas do e-gestor. Esses pedidos devem ser enviados ao coordenador regional, que por sua vez consolida-os e envia para a coordenador estadual (CEN), que sempre deve estar atento aos estoques municipais, regionais e estadual.

O coordenador estadual solicita o quantitativo necessário para atender todos os 144 municípios. Todos esses pedidos devem ser oficialmente solicitados através de documentos.

- b. Entrega – Quando o insumo chegar ao Almoxarifado da Assistência Farmacêutica da SESPA, o coordenador estadual confere no Sistema de informação da empresa prestadora de serviço do almoxarifado e começa a fazer a distribuição aos CRS, enviando o quantitativo solicitado por eles, onde é gerado um número da requisição. Um e-mail será enviado a cada CRS comunicando que o insumo foi liberado e informando o número da requisição e a quantidade enviada por município.
- A entrega do CRS para os municípios ocorrerá mensalmente, de acordo com a inserção dos dados no e-gestor. Se isso não ocorrer, o município deixará de receber sua meta mensal, que será acumulada até que seja feita a inserção de dados.
- c. Solicitamos a leitura detalhada do documento em questão para saber todas as responsabilidades dos coordenadores.

MONITORAMENTO

Será realizado nas 3 esferas (estadual, regional e municipal) pelo sistema e-gestor. Os municípios de posse do quantitativo suficiente para atender sua meta deverão inserir os dados dos consolidados no sistema do e-gestor, sob a penalidade de não receber a próxima remessa.





FUNDO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)

A fim de apoiar a implementação da PNAN nos Estados e nos Municípios, o Ministério da Saúde realiza repasse de incentivo financeiro FAN desde 2006 com parte do Bloco de Financiamento de Gestão do SUS no componente de implantação de ações e serviços de saúde.

O FAN caracteriza-se como recurso de custeio, fundo a fundo, com periodicidade de repasse anual, cujos valores são relativos ao porte populacional (com base no Censo do IBGE) e se destina, prioritariamente, à:

- organização da atenção nutricional na Rede de Atenção à Saúde (RAS), em especial no âmbito da Atenção Primária em Saúde (APS) e;
- apoio à estruturação e qualificação das ações de alimentação e nutrição no SUS, integrando um rol de ações estratégicas do setor saúde para a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e garantia do DHAA.

O FAN tem com diretrizes prioritárias:

- promoção da alimentação adequada e saudável;
- realização da vigilância alimentar e nutricional;
- prevenção dos agravos relacionados à alimentação e nutrição, especialmente sobrepeso e obesidade, desnutrição, anemia por deficiência de ferro, hipovitaminose A e beribéri;
- qualificação da força de trabalho em alimentação e nutrição.

O público da ação é composto pelas 27 Unidades Federativas, as capitais brasileiras e Municípios com contingente populacional definido em cada uma das seguintes portarias de 2020:

- Portaria nº 802/GM/MS, de 14/04/20 - destina aos Estados, Distrito Federal e Municípios que possuam população superior a 150.000 (cento e cinquenta mil) habitantes (estimativa IBGE, 2018)
- Portaria nº 1012/GM/MS, de 18/04/20 – destina às Secretarias de Saúde dos Municípios que possuem população entre 30.000 e 149.999 habitantes.



SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN)

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), que tem por objetivo realizar a gestão das informações de Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN), é uma ferramenta para o monitoramento da situação alimentar e nutricional e de apoio aos profissionais de saúde para o diagnóstico local das condições e agravos alimentares e nutricionais, identificando fatores de risco ou proteção para as condições de saúde da população atendida nos serviços de Atenção Básica no Brasil.

O Sisvan está disponível para o registro e a disseminação de informações acerca da avaliação antropométrica e de consumo alimentar da população atendida na Atenção Básica, em todos os ciclos da vida (criança, adolescente, adulta, idosa ou gestante), independente do sexo, raça/cor, escolaridade ou pertencimento à povo ou comunidade tradicional.

A primeira versão do Sisvan foi disponibilizada em 2004 e, ao longo do tempo, tem sido aprimorada. Atualmente utiliza-se a versão 3.0 do sistema lançada em 2017 com objetivo de otimizar a integração do Sisvan com o e-SUS Atenção Básica, sendo utilizado o Cartão Nacional de Saúde (CNS) para a unificação. O sistema, que pode ser acessado com um computador ou outro dispositivo conectado à internet por meio do endereço eletrônico: <http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/sisvan>, tem 2 opções de acesso:

- **Módulo Público:** pode ser acessado por qualquer pessoa e permite a visualização de relatórios consolidados de estado nutricional e de consumo alimentar, agregados por município, região de saúde, estado, macrorregião e Brasil.
- **Módulo Restrito:** pode ser acessado por gestores ou técnicos municipais e estaduais envolvidos em ações de VAN para
 - Registrar os acompanhamentos de estado nutricional e de consumo alimentar realizados durante os atendimentos de usuários da Atenção Básica;
 - Gerar relatórios individualizados e consolidados com maior detalhamento, como lista nominal de pessoas acompanhadas com a respectiva classificação do estado nutricional ou ainda a lista nominal daqueles que não foram acompanhados no último ano.

Atenção: Aos gestores e técnicos municipais é permitido o uso das funcionalidades que envolvem o registro de dados de acompanhamentos e extração de relatórios. Já gestores e técnicos estaduais visualizam o sistema e geram relatórios, bem como cadastram programas e grupos de atendimento do âmbito estadual

RECURSO FINANCEIRO

O registro de informações, tanto de antropometria quanto de consumo alimentar, não está associado, diretamente, ao repasse de recurso financeiro em nível federal. No entanto, a Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) tem o papel de proporcionar o diagnóstico local e oportuno dos agravos alimentares e

nutricionais, bem como a identificação de fatores de risco ou proteção, tais como o aleitamento materno e a introdução da alimentação complementar, que possibilitarão a constante avaliação e organização da atenção nutricional no SUS, permitindo a identificação de prioridades de acordo com o perfil alimentar e nutricional da população assistida.

Nesse sentido, em 2011 foi criado um incentivo financeiro para apoiar a estruturação da vigilância alimentar e nutricional em UBS (adesão a PMAQ) e em polos do programa “Academia da Saúde”, por meio da aquisição de equipamentos antropométricos adequados para averiguar as medidas adotadas no SISVAN: peso, comprimento, altura e circunferência da cintura. São medidas simples, porém sujeitas a serem executadas de maneira inadequada pelo profissional responsável que não esteja devidamente treinado ou pela aquisição, instalação e manutenção inadequada dos equipamentos utilizados.

Equipamentos antropométricos:

- Balança (mesa e plataforma);
- Antropômetro (horizontal ou infantômetro e o vertical ou estadiômetro);
- Fita métrica.

Em 2020, 12 municípios do Pará foram habilitados por meio da Portaria nº1210, de 18 de maio de 2020, a receberem recursos financeiros para estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional por meio da compra de equipamentos antropométricos adequados: Belém, Breu Branco, Faro, Gurupá, Marabá, Nova Esperança do Piriá, Oriximiná, Palestina do Pará, Primavera, Quatipuru, Santa Cruz do Arari e Santarém Novo.

FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

Cadastro

Antes de iniciar o cadastro de um novo indivíduo, o sistema solicita localizá-lo de modo a saber se o usuário já tem cadastro na base de dados do Sisvan, por meio do Nome, Cartão Nacional de Saúde (CNS), Fase da vida, Sexo e/ou Data de nascimento. Caso não seja localizado, é feito o cadastro em 2 blocos: dados do indivíduo e dados do domicílio.

Registro de Acompanhamento Nutricional

O registro de dados antropométricos depende do sexo e idade a quem se refere o acompanhamento, sendo necessário coletar, no mínimo, dados de peso, estatura, perímetro da cintura (em adultos); perímetro da panturrilha (em idosos); e excepcionalmente deverão ser coletados o peso ao nascer, no caso de crianças menores de dois anos e para grávidas, será necessário inserir a informação de DUM (data da última menstruação).

O registro do consumo alimentar é feito com base nos alimentos consumidos no dia anterior e comportamentos que se relacionam à alimentação saudável ou não saudável, dependendo da faixa etária do indivíduo que está sendo acompanhado, sendo necessário responder todas as questões do bloco.

Relatórios

Os relatórios individualizados permitem a identificação nominal das pessoas acompanhadas nos serviços de Atenção Básica com registro no Sisvan.

Os relatórios consolidados são uma importante ferramenta de disseminação de informação acerca do

estado nutricional e marcadores do consumo alimentar da população atendida na Atenção Básica.

INTEGRAÇÃO DO SISVAN COM OUTROS SISTEMAS

A base de dados do Sisvan é composta pelos registros de acompanhamentos provenientes do Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde (Sistema BFA), incorporados ao final de cada vigência; do e-SUS AB, incorporados gradativamente ao SISAB, respeitando-se o cronograma de envio de dados pelas equipes de Atenção Básica para a base nacional e exportados para o Sisvan após processamento e validação, o que ocorre em até 10 dias após o prazo máximo de envio de dados referentes à Atenção Básica para o SISAB e do próprio Sisvan.





ESTRATÉGIA DE FORTIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM MICRONUTRIENTES EM PÓ – NUTRISUS

O QUE É?

O NutriSUS foi lançado em março de 2015, pelos Ministério da Saúde, da Educação e de Desenvolvimento Social, com o objetivo de intensificar o crescimento infantil, prevenção e controle da anemia e outras carências nutricionais específica da infância.

ONDE OCORRE?

Em creches que participam do Programa Saúde na Escola (PSE).

COMO IMPLANTÁ-LO?

Para sua implantação é necessário selecioná-la no processo anual de adesão ao PSE. A ação está inserida no Componente II – Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos e se enquadra como optativa, ou seja, será complementar às ações essenciais pactuadas pelo gestor municipal.

COMO FUNCIONA?

Através da adição de um sachê (1g) composto por uma mistura de vitaminas e minerais em pó em uma das refeições diárias, por 60 dias (segunda a sexta-feira), oferecidas às crianças de 6 a 48 meses de idade, no ambiente escolar, nas creches, até finalizar o ciclo de 60 sachês. Deve acontecer uma pausa de 3 a 4 meses e, após esse período, começa o outro ciclo de 60 dias.

NO PARÁ

Dezoito municípios paraenses, no ciclo entre 2019 e 2020, aderiram ao NUTRISUS quando fizeram a adesão ao PSE, com uma meta de suplementar 4.849 crianças. Também participam da Estratégia os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).



PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL

Consiste em um conjunto de ações a serem implementadas com o objetivo de contribuir para o enfrentamento da obesidade infantil no país por meio de ações a serem realizadas no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE), para as crianças matriculadas na Educação Infantil (creches e pré-escolas) e Ensino Fundamental I. O controle da obesidade infantil no ambiente escolar será direcionado para as crianças menores de 10 anos, fortalecendo o cuidado integrado e multidisciplinar, por meio do desenvolvimento das ações e metas descritas na tabela abaixo:

Ação	Meta	Indicadores	Fórmula de Cálculo	Fonte
1. Avaliar o estado nutricional (peso e altura) das crianças menores de 10 anos.	Estado nutricional de todas as crianças da educação infantil (creches e pré-escolas) e ensino fundamental I de escolas do PSE do ciclo 2019/2020 avaliados.	Número de crianças menores de 10 anos com estado nutricional avaliados no município.	Número de crianças menores de 10 anos com estado nutricional avaliado no ano corrente através do Sisvan;	SISVAN Meta: Censo escolar (INEP)
2. Ofertar atividades coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável para as crianças matriculadas na Educação Infantil e Ensino Fundamental I nas escolas que participam do PSE no seu município.	Mínimo de 4 atividades coletivas na temática de promoção da Alimentação Adequada e Saudável, por escola incluída no programa, no primeiro ano do ciclo.	% de escolas pactuadas no PSE que realizaram no mínimo 4 atividades coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável.	Número de escolas no PSE que realizaram, no mínimo, 4 atividades coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável / número de escolas no PSE * 100.	Sisab
3. Ofertar atividades coletivas de promoção das práticas corporais e atividades físicas para as crianças matriculadas na Educação Infantil e Ensino Fundamental I nas escolas que participam do PSE no seu Município.	Mínimo de 4 atividades coletivas de promoção das práticas corporais e atividades físicas ² , por escola incluída no programa, no primeiro ano do ciclo;	Percentual de escolas pactuadas no PSE que realizaram no mínimo 4 atividades coletivas de práticas corporais e atividades físicas.	Número de escolas no PSE que realizaram, no mínimo, 4 atividades coletivas de práticas corporais e atividades físicas / nº de escolas	Sisab

			no PSE * 100	
4. Atender as crianças identificadas com obesidade por meio de intervenção e cuidado na rede de atenção primária à saúde do município.	Atendimento individual para crianças da educação infantil e ensino fundamental I identificadas com obesidade realizado.	Número de atendimentos individuais para a condição avaliada (obesidade) na população de crianças da educação infantil e ensino fundamental I com obesidade.	Total de atendimentos individuais para crianças ¹ matriculadas na educação infantil e ensino fundamental I com obesidade realizados por profissionais de nível superior (EAB ou NASF).	Sisab

*Todas as crianças avaliadas deverão estar identificadas com o número do Cartão Nacional de Saúde. **As atividades coletivas de práticas corporais e atividades físicas não são as aulas de educação física regularmente oferecidas pela escola. Busque informações no caderno temático “Práticas Corporais, Atividade Física e Lazer” do PSE, disponível em http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/caderno_praticas_corporais_atividade-fisica_lazer.pdf

FINANCIAMENTO

Os municípios que aderiram ao Programa Saúde na Escola (PSE) e se comprometeram com as ações e metas do Programa Crescer Saudável receberão incentivo financeiro adicional ao custeio pago ao PSE para implementação de ações de prevenção e controle da obesidade infantil em escolares. Os recursos serão repassados fundo a fundo em parcela única anual. A portaria que habilita o repasse financeiro para os municípios que alcançaram as metas do programa Crescer Saudável é publicada no Diário Oficial da União em meados do mês de agosto de cada ano. O montante de recursos a ser transferido para cada município leva em consideração o número de escolares matriculados nas escolas aderidas ao PSE e a prevalência municipal de obesidade em crianças menores de 10 anos no ano de 2017, segundo dados do Sisvan. A avaliação do cumprimento de metas será aplicada a cada um dos indicadores e levará em conta a seguinte graduação mostrada na tabela abaixo:

Cumprimento da meta (%)	Valor a ser repassado (%)
76 a 100	100
51 a 75	75
26 a 50	50
1 a 25	25
< 1	0

Digamos que em 2019 o município tenha cumprido 80% da meta 1 (avaliação do estado nutricional). Neste caso, em 2020 este município receberá 100% de 250,00. Na meta 2 (4 ações coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável por escola pactuada), suponhamos que o município tenha cumprido 50% e então receberá 50% de 250 (R\$ 125,00). Na meta 3 (4 ações coletivas de promoção de práticas corporais e atividade física por escola pactuada), suponhamos que o município tenha cumprido 20%, e então receberá, em 2020, 25% de 250,00 (R\$ 62,50). E, na meta 4, suponhamos que o município tenha cumprido 0%, ou seja, nenhuma criança com obesidade passou por atendimento individual na atenção primária. Neste caso o município receberá, em 2020, 0% de 250,00 (R\$ 0,00). Somando os valores correspondentes ao cumprimento das 4 metas, temos o total de recursos a serem recebidos pelo município em 2020: R\$ 250,00 + R\$ 125,00 + R\$ 62,50 + R\$ 0,00 = 437,50.

COMO FAZER O REGISTRO DAS AÇÕES?

As atividades coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável, promoção das atividades físicas e práticas corporais e o registro dos dados de peso e altura, devem ser registradas na ficha de atividade coletiva do E-Sus AB versão 3.2. A intervenção e cuidado das crianças identificadas com obesidade devem ser registradas na ficha de atendimento individual do E-Sus AB versão 3.2.

As informações coletadas nas fichas devem ser inseridas no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab), por meio das fichas de atendimento individual e atividade coletiva. O registro dos dados de peso e altura podem ser realizados no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) e no Sisab.

MONITORAMENTO

Será realizado por meio dos sistemas de informação já disponíveis no SUS e que têm sido utilizados pelos municípios: Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab) e Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan).

COMO FAZER A ADEÇÃO AO PROGRAMA?

A adesão é realizada através do site do e-gestor: <https://egestorab.saude.gov.br>. Após finalizar a adesão ao PSE aparecerá um link que leva para a adesão do Programa Crescer Saudável.





ESTRATÉGIA PARA O FORNECIMENTO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS (FNE)

Os cuidados em Terapia Nutricional (TN), historicamente reconhecidos e realizados no âmbito hospitalar, tem se apresentado como demanda crescente na atenção à saúde em âmbito domiciliar, o que tem gerado a necessidade de desenvolvimento de estratégias para sua organização e qualificação.

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) tem como propósito a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição.

Diante da atual situação de saúde da população brasileira, a PNAN define como prioritárias as ações preventivas e de tratamento da obesidade, da desnutrição, das carências nutricionais específicas e das doenças crônicas não transmissíveis relacionadas à alimentação e nutrição. Mas também aponta como demandas para a atenção nutricional no Sistema Único de Saúde (SUS) o cuidado aos indivíduos que apresentam necessidades alimentares especiais.

Sabe-se que existem inúmeras doenças e agravos a saúde que, assim como as próprias fases do curso da vida, podem causar mudanças nas necessidades nutricionais e a forma de se alimentar de cada indivíduo. As necessidades alimentares especiais são definidas na PNAN como:

As necessidades alimentares, sejam restritivas ou suplementares, de indivíduos portadores de alteração metabólica ou fisiológica que cause mudanças, temporárias ou permanentes, relacionadas à utilização biológica de nutrientes ou a via de consumo alimentar (enteral ou parenteral). (BRASIL, 2012a)

Nesse sentido, podem ser considerados “indivíduos com necessidades alimentares especiais” aqueles acometidos por erros inatos do metabolismo, intolerâncias e alergias alimentares, doença celíaca, HIV/AIDS, diabetes, câncer, nefropatias, os que se encontram em recuperação pós-cirúrgica, as crianças prematuras, entre tantas outras situações.

A ampliação da população idosa, o aumento do número de pessoas com doenças crônicas, o crescimento das vítimas de acidentes de trânsito e de situações de violência, podem ter como consequência alterações clínicas relacionadas à deglutição e/ou integridade do trato gastrointestinal. Em muitos desses casos é necessária uma via alternativa e atenção diferenciada quanto à alimentação.

Diante disso, a atenção às necessidades alimentares especiais por meio da TN, historicamente reconhecida e realizada como atividade da atenção hospitalar, necessita ser organizada e qualificada como prática de cuidado no âmbito domiciliar e devem estar inseridos nas linhas de cuidado integral baseadas nas necessidades dos indivíduos, reduzindo assim, a fragmentação da assistência.

Apesar destes produtos possuírem “status” de alimento-medicamento, não são disponibilizados através de programa instituído pelo Ministério da Saúde no SUS, não são incorporados pela Relação Nacional de Medicamentos – RENAME e nem pela lista de medicamentos especializados.

O Estado do Pará atualmente não possui instituído um Programa de Nutrição Especializada ou protocolo clínico e diretriz terapêutica de acompanhamento e dispensação de fórmulas nutricionais para portadores de alergia à proteína do leite de vaca ou portadores de necessidades alimentares especiais (restritivas, suplementares ou que necessitem de via de consumo alimentar não oral), na qual o usuário seja encaminhado/referenciado, acompanhado ambulatoriamente e que receba tratamento adequado e a dispensação do produto, caso necessário, até o término do tratamento.

Assim, com o objetivo de organizar, normatizar e avaliar a real necessidade da solicitação dos referidos produtos, foi elaborada a ***Instrução Normativa Nº 003, de 24 de setembro de 2015***, a qual dispõe sobre o processo para obtenção de fórmulas no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado do Pará - SESPA (ANEXO I).

CRITÉRIOS PARA SOLICITAÇÃO DAS FÓRMULAS

A secretaria de saúde atenderá aos municípios que têm a PAC média e alta complexidade sob gerência do Estado, ou seja, os municípios em gestão básica de atenção à saúde. Quanto aos municípios que têm PAC média e alta complexidade sob gerência própria (gestão plena) deverão atender a essas demandas e fornecer a fórmula nutricional ao seu munícipe. Todo o pedido deverá ser encaminhado à SESPA, através do Centro Regional de Saúde via PAE à Assessoria Especial.

Caso o paciente/requerente ou responsável **não apresente** todos os critérios e/ou documentos necessários para o fornecimento da fórmula nutricional especial, o processo ficará em aberto na Assessoria Especial para adequação, no prazo de 30 dias. Caso contrário, haverá cancelamento.

A solicitação inicial deverá ser feita pelo médico ou nutricionista da Atenção Básica do SUS, após avaliação e diagnóstico clínico nutricional, sendo preenchido corretamente o Laudo para Solicitação de Fórmulas Nutricionais Especiais (FNE), sendo que terão 30 (trinta) dias para efeito de dispensação na rede estadual, a partir da data de solicitação via protocolo e atenderá ao usuário pelo período máximo de 03 (três) meses, podendo ser renovada conforme avaliação médica e/ou nutricional do usuário, observando-se os critérios técnicos-científicos vigentes e estando o mesmo vinculado aos protocolos dos programas e ações de atenção básica estabelecidos no âmbito do SUS:

- ☐ Alimentos padronizados para dieta enteral;
- ☐ Alimentos padronizados para suplementação nutricional;
- ☐ Fórmulas infantis especiais padronizadas.

O profissional responsável pelo acompanhamento clínico-nutricional de referência do usuário deverá realizar a reavaliação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, com o objetivo de definir a necessidade de continuidade ou suspensão do fornecimento da FNE.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Para o recebimento da FNE, o processo deverá ser devidamente instruído de acordo com o disposto no item anterior, bem como os laudos e prescrições atualizados, além de toda a documentação relacionada a seguir:

- Cópia legível do Documento de Identidade (RG) e CPF do requerente;
- Cópia legível do Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) do requerente;
- Cópia legível do Documento de Identidade (RG) e CPF do responsável legal (aos menores de 18 anos);
- Comprovante de residência atualizado, no nome do requerente ou de seu representante legal, ou declaração de residência e o número de telefone para contato;
- Laudo para Solicitação de FNE fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde, a ser preenchido pelo médico ou nutricionista responsável (**ANEXO II**);
- Termo de Consentimento e Compromisso do Fornecimento de FNE (**ANEXO II**);
- Prescrição (receita) com a quantidade de FNE necessária para até 90 (noventa) dias, a ser renovada pelo médico e/ou nutricionista da UBS de referência do SUS;

O quantitativo a ser dispensado atenderá o referido paciente por um período de 90 (noventa) dias. Após o término, caso haja necessidade de dar continuidade ao tratamento nutricional, deverá ser dado entrada em novo processo.

PADRÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS FORNECIDAS PELA SESPA

As fórmulas nutricionais especiais obedecem aos seguintes descritivos:

- 01- Fórmula infantil de partida para lactentes (0 a 6 meses de idade) com proteínas lácteas e prebióticos. Lata com 400 g.
- 02- Fórmula infantil de seguimento para lactentes (6 a 12 meses de idade) com proteínas lácteas e prebióticos. Lata com 400 g.
- 03- Fórmula infantil de partida para lactentes (0 a 6 meses de idade) à base de proteína isolada de soja. Acrescida de ferro. Isenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. Lata com 400 g.
- 04- Fórmula infantil de seguimento para lactentes (6 a 12 meses de idade) à base de proteína isolada de soja. Acrescida de ferro. Isenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. Lata com 400 g.
- 05- Fórmula infantil especial para crianças nos casos de má absorção, intolerância ou alergia alimentar a proteínas do leite de vaca e soja. Semi-hidrolisado e hipoalergênica, à base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite de vaca. Isenta de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. Lata com 400g.
- 06- Fórmula infantil para lactentes, hipoalergênica, à base de proteína de soro de leite de vaca extensamente hidrolisada, com lactose. Sem gluten. Lata com 400 g.
- 07- Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ou crianças de primeira infância, destinadas para necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose, à base de aminoácidos livres, especializada para crianças. Isenta de proteínas alergênicas, sacarose, lactose, galactose, frutose e glúten. Lata com 400 g.
- 08- Fórmula elementar à base de aminoácidos livres, nutricionalmente completa para crianças acima de 01 ano de idade com alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. Isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, galactose, frutose e glúten. Lata com 400 g.
- 09- Fórmula elementar à base de aminoácidos livres, nutricionalmente completa para crianças até 10 anos de idade com alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. Isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, galactose, frutose e glúten. Lata com 400g.
- 10- Alimento para situações metabólicas especiais, formulado para portadores de alergias às proteínas do leite de vaca, do leite de soja e de hidrolisados. Composto de 100% aminoácidos livres. Sabor baunilha. Lata com 400g.

- 11- Suplemento alimentar em pó, nutricionalmente completo para crianças de 01 a 10 anos de idade hipercalórico e hiperprotéico quanto à diluição padrão. Rico em vitaminas e minerais. Isento de lactose e glúten. Lata com 400 g.
- 12- Dieta enteral nutricionalmente completa, para crianças, normocalórica (1.0 a 1.2 cal/ml) e normoprotéica (10 a 16%). Isenta de fibras, sacarose, lactose e glúten. Embalagem líquida com 500 ml.
- 13- Dieta enteral nutricionalmente completa para crianças, hipercalórica (1.3 a 1.5 cal/ml) e normoprotéica (10 a 16%). Isenta de fibras, sacarose, lactose e glúten. Embalagem com 500 ml.
- 14- Suplemento nutricional específico para melhorar o processo de cicatrização, hiperprotéico, não inferior a 21% de proteínas e com micronutrientes que ajudam na cicatrização. Sabores variados. Frasco com 200 ml.
- 15- Suplemento nutricional completo, hipercalórico (mínimo 1.5 cal/ml), hiperprotéico (mínimo 20%) e normolipídico. Isento de lactose e glúten. Sabores variados. Frasco com 200 ml.
- 16- Dieta enteral nutricionalmente completa, normocalórica (mínimo 1.2 cal/ml) e normoprotéica (10 a 16%) e acrescida de fibras. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Frasco com 1.000 ml.
- 17- Dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica (1.3 a 1.5 cal/ml) e normoprotéica (10 a 16%) e acrescida de fibras. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Frasco com 1.000 ml.
- 18- Dieta enteral nutricionalmente completa, normocalórica (mínimo 1.2 cal/ml) e normoprotéica (10 a 16%). Isenta de sacarose, lactose, glúten e fibras. Frasco com 1.000 ml.
- 19- Dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica (1.5 cal/ml) e normoprotéica (10 a 16%). Isenta de sacarose, lactose, glúten e fibras. Frasco com 1.000 ml.
- 20- Dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica (mínimo 1.5 cal/ml) e hiperprotéica (mínimo 17%). Isenta de sacarose, lactose, glúten e fibras. Frasco com 1.000 ml.
- 21- Dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica (mínimo 1.5 cal/ml) e hiperprotéica (mínimo 17%) e com fibras. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Frasco com 1.000 ml.
- 22- Dieta enteral para auxiliar controle de diabetes e situações de hiperglicemia. Normocalórica, à base de carboidratos com baixo índice glicêmico e com fibras. Isenta de sacarose e glúten. Frasco com 1000 ml.
- 23- Suplemento alimentar nutricionalmente completo com flexibilidade de diluição de normocalórica a hipercalórico. Rico em vitaminas e minerais. Sabores variados. Latas com 400 g.

24- Dieta enteral ou oral, nutricionalmente completa para uso a partir de 01 ano de idade, normocalórica e normoprotéica, com presença de TGF-B2. Isento de lactose e glúten. Indicada para pacientes com doença de Crohn. Lata com 400 g.

25- Dieta em pó, oligomérica de alta absorção, nutricionalmente completa normocalórica e hiperproteica. Indicada para pacientes com síndrome de má absorção e na síndrome do intestino curto. Isento de lactose e glúten. Envelope de até 76 gramas.

26- Módulo de fibras alimentares a base de fibras solúveis e insolúveis. Lata com até 250 gramas.

27- Espessante alimentar instantâneo indicado para pacientes com disfagia ou dificuldade de deglutição. Lata com até 300 gramas.

NÃO É DISPENSADO

A SESPA, por meio desse **Estratégia** não disponibilizará os seguintes itens:

- Insumos (material usado para pacientes em alimentação via nasogástrica ou enteral ou gastrostomia): seringas, equipos para via alternativa de alimentação (sonda nasogástrica - SNG, gastrostomia – GTT, frascos descartáveis para dieta enteral e/ou micropore);
- Material de Higiene;
- Medicamentos.

ANEXO I

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

ANEXO 2

FORMULARIO PARA SOLICITAÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS - LFN

Data: ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO

Nome completo: _____

Sexo: () M () F Data de nascimento (DN): ____/____/____ Idade: _____

CPF: _____ RG: _____ Cartão SUS (CNS): _____

Endereço (rua, nº, bairro): _____

Município de residência: _____

Telefone(s): _____ UF: _____ CEP: _____

Nome completo do responsável: _____

CPF: _____ RG: _____

INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA

Doença principal: _____ CID: _____

Diagnóstico (s) secundário e CID: _____

Exames, diagnóstico ou complementar (COPIA SE POSSIVEL):

Assinalar o agravo que justifica a indicação da terapia nutricional:

() Alergia alimentar com exame comprobatório

() Afagia / Disfagia por alteração mecânica da deglutição ou trânsito digestivo

() Síndrome de má absorção

() Afagia / Disfagia por doença neurológica

() Desnutrição moderada a grave

() Transtorno de mobilidade intestinal () Outro: _____

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA

Peso (Kg): _____ () Atual () Estimado

Estatura (cm): _____ () Atual () Estimado IMC : _____ kg/m²

Estado Nutricional: _____

VIA DE ADMINISTRAÇÃO DA TERAPIA NUTRICIONAL

() VO () TNE+VO () TNE EXCLUSIVA () TNE+TPP

VIA DE ACESSO

Sonda: () Nasogástrica () Nasoentérica () Gastrostomia () Jejunostomia

Terapêuticas utilizadas anteriormente: _____

Descritivo da fórmula solicitada: _____

Volume e fracionamento/dia: _____

Total /Mês: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL SOLICITANTE:

Nome do estabelecimento: _____

CNES: _____

Nome do profissional: _____

CRM/CRN _____ CPF: _____

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

ANEXO 1

TERMO DE CONSENTIMENTO E COMPROMISSO DO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS

Eu, _____,
Paciente / responsável pelo paciente _____, abri
o processo nº _____ solicitando fórmula nutricional especial, li e
concordo com os termos abaixo discriminados:

1. A entrega da fórmula nutricional especial ocorre na Coordenação Estadual de Assistência Farmacêutica do Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde Pública (CAF/DEAF/SESPA);
2. A CAF entrará em contato logo após a aquisição da fórmula nutricional especial, para que o responsável possa fazer a retirada.
3. A fórmula nutricional especial adquirida pela SESPA corresponde a especificações técnicas, desta forma, durante o tratamento nutricional o paciente/responsável poderá receber produtos com nomes comerciais diferentes, porém o paciente terá a garantia da similaridade do produto com o prescrito para a patologia de base apresentada (Lei nº 8666/1993);
4. Caso a fórmula nutricional especial não seja retirada da CAF/DEAF/SESPA no prazo de 30 dias a partir da data de contato, a mesma poderá ser remanejada para outros pacientes;
5. Caso ocorra atraso por parte da SESPA em fornecer o benefício, o paciente/responsável será avisado via telefone pela CAF/DEAF/SESPA;
6. O fornecimento de fórmula nutricional especial será feito para o prazo máximo de 90 dias para cada processo;
7. Um novo fornecimento de fórmula nutricional especial só será possível, mediante abertura de novo processo;
8. O paciente/responsável está consciente de que não poderá sob hipótese alguma, comercializar ou doar produtos recebidos pela SESPA, e que estes são exclusivos para uso no domicílio do paciente;
9. A liberação integral ou parcial da fórmula nutricional especial solicitada depende da avaliação nutricional, social e jurídica.

De acordo,

Assinatura: _____

Paciente/responsável pelo paciente

Referências

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução RDC nº 63**, de 6 de julho de 2000. Aprova o Regulamento Técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição Enteral. Disponível em: <<http://portal.anvisa.gov.br>>. Acesso em: 11 abr. 2017.

BRASIL. **Lei nº 10.836**, de 9 de janeiro de 2004. Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências. Diário Oficial União. Brasília, DF, 12 de janeiro de 2004.

BRASIL. **Portaria Interministerial MS/MDS nº 2.509**, de 18 de novembro de 2004. Dispõe sobre as atribuições e normas para a oferta e o monitoramento das ações de saúde relativas às condicionalidades do PBF. Diário Oficial União. Brasília, DF, 22 de novembro de 2004.

BRASIL. **Portaria MS/GM nº 2.975**, de 14 de dezembro de 2011. Apoiar financeiramente a estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional. Diário Oficial União. Brasília, DF, 25 de maio de 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Política Nacional de Alimentação e Nutrição**. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2012. 84 p. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_alimentacao_nutricao.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Manual orientador para aquisição de equipamentos antropométricos**. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2012. 18 p. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_equipamentos_2012_1201.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Manual de condutas gerais do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A**. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2013. 35 p. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_condutas_suplementacao_vitamina_a.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Marco de referência da vigilância alimentar e nutricional na atenção básica**. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2015. 56 p. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/marco_referencia_vigilancia_alimentar.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. **NutriSUS - Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e minerais) em pó: manual operacional**. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2015. 52 p. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nutrisus_estrategia_fortificacao_alimentacao_infantil.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Melhor em Casa: cuidados em terapia nutricional**. Caderno de Atenção Domiciliar, v. 3. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2015. 90 p. Disponível em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidados_terapia_domiciliar_v3.pdf> Acesso em: 23 fev. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Ofício Circular nº 017/2016-DAB/SAS/MS**, de 23 de junho de 2016. Encerramento da suplementação de puérperas com megadoses de vitamina A no Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/oficio_17-2016_encerramento_suplement_vit_a.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Manual Operacional para uso do sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN versão 3.0**. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2017. 39p. Disponível em: <<http://sisaps.saude.gov.br/sisvan/public/file/ManualDoSisvan.pdf>>. Acesso em: 19 fev. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Instrutivo Programa Crescer Saudável 2019/2020**. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2019. 21p. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/pse/instrutivo_crescer_saudavel_2019_2020.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2021.

BRASIL. Ministério da Cidadania. Secretaria Especial de Desenvolvimento Social. **Guia para acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família**. Brasília-DF: Ministério da Cidadania, 2020. 56 p. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_familia/Guias_Manuais/Acompanhamento_condicionalidades.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2021.

BRASIL. **Portaria MS/GM nº 802**, de 14 de abril de 2020. Habilita Estados, Distrito Federal e Municípios ao recebimento de incentivo para estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição, com base na Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN, referente ao exercício financeiro de 2020. Diário Oficial União. Brasília, DF, 15 de abril de 2020.

BRASIL. **Portaria MS/GM nº 1.210**, de 18 de maio de 2020. Habilita municípios a receberem recursos financeiros para estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional por meio da compra de equipamentos antropométricos adequados. Diário Oficial União. Brasília, DF, 25 de maio de 2020.

BRASIL. **Portaria MS/GM nº 1.012**, de 25 de maio de 2020. Estabelece, no ano de 2020, incentivo de custeio para a estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição pelas Secretarias de Saúde dos Municípios que possuem população entre 30.000 e 149.999 habitantes com base na Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN. Diário Oficial União. Brasília, DF, 25 de maio de 2020.

BRASIL. **Portaria nº 2.141**, de 14 de agosto de 2020. Habilita Municípios e Distrito Federal ao recebimento do incentivo financeiro para implementação das ações do Programa Saúde na Escola no segundo ano do ciclo 2019/2020 e destina recursos financeiros para os municípios e Distrito Federal aderidos ao Programa Crescer Saudável que alcançaram as metas do Programa. Diário Oficial União. Brasília, DF, 18 de agosto de 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Passo a Passo para Adesão ao Programa Saúde na Escola**. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2020. 03 p. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/geral/crescer_saudavel_2019.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2021.

BRASIL. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. FAN – Financiamento. Disponível em: <<https://aps.saude.gov.br/politicas/pnan/financiamento>>. Acesso em: 19 fev. 2021.

SÃO PAULO. **Protocolo clínico para normatização da dispensação de fórmulas infantis especiais a pacientes com alergia à proteína do leite de vaca, atendidos pelo sistema único de saúde do estado de São Paulo.** Diário oficial. São Paulo, SP, 27 de novembro de 2014.

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ
POR TODO O PARÁ



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL